

Examen fédéral de médecine Répétitoire 2018 - Pédiatrie

Médecin responsable :

Dr H. Chehade

Médecin adjoint

Département Femme-Mère-Enfant

Quel énoncé n'est pas correct pour le néphroblastome (tumeur de Wilms) ?

- A. Il touche plus fréquemment les enfants après l'âge de 8 ans
- B. Il provoque souvent une dilatation abdominale évidente
- C. Le dosage des métabolites urinaires des catécholamines est normal
- D. Est la plus fréquente des tumeurs rénales malignes de l'enfant
- E. Des malformations, par ex. aniridie, hémihypertrophie corporelle, et pseudo-hermaphrodisme masculin, sont plus fréquentes chez les enfants avec un néphroblastome

Réponse A

Une hyponatrémie n'est pas observée dans :

- A. Un hypoaldostérisme
- B. Un diabète insipide
- C. Une sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique
- D. Un apport liquidien normal en présence d'une insuffisance rénale aiguë
- E. Une déplétion en potassium

Réponse B : un diabète insipide

Laquelle des pathologies suivantes n'est pas associée à la neurofibromatose de type 1 (maladie de von Recklinghausen) ?

- A. Des taches café-au-lait contenant de la mélanine
- B. Un syndrome de West (spasmes infantiles)
- C. Une hypertension artérielle
- D. Des neurofibromes plexiforme
- E. Des hamartomes iriens (nodules de Lisch)

Réponse B : un syndrome de West (spasmes infantiles)

L'ingestion orale de pétrole chez un enfant de deux ans entraîne en tout premier lieu :

- A. Un oedème toxique du poumon
- B. Une défaillance rénale
- C. Des convulsions d'origine cérébrale
- D. Une défaillance hépatique
- E. Aucune des événements ci-dessus

Réponse A : un oedème toxique du poumon

Le neuroblastome est l'une des tumeurs malignes les plus fréquentes de la petite enfance. Il est caractérisé par:

- A. Dans 90 % des cas, le neuroblastome est diagnostiqué avant l'âge de 5ans
- B. La présence d'une hypotension artérielle
- C. Les sites métastatiques les plus fréquents sont les poumons et le cerveau
- D. Une diminution des catécholamines urinaires
- E. Des convulsions

Réponse: A

Une jeune fille de 9 ans se plaint depuis 2 mois de céphalées. A plusieurs reprises on lui a mesuré au bras droit une tension artérielle de 145/90 mm Hg. A son âge :

- A. Il s'agit le plus probablement d'une hypertension artérielle essentielle
- B. Une cause rénale à l'hypertension est très peu probable
- C. Un profil des tensions artérielles sur 24 heures ne peut pas être effectué
- D. Une coarctation de l'aorte doit être exclue
- E. Le but du traitement vise une tension au dessous du 50^e percentile

Réponse D

Une isosthénurie est présente lors :

- A. De cystite aiguë
- B. D'insuffisance rénale chronique
- C. De glomérulonéphrite aiguë
- D. De syndrome néphrotique
- E. De rachitisme hypophosphatémique

Réponse B : d'insuffisance rénale chronique

L'acidose tubulaire rénale se manifeste le plus souvent par :

- A. Une mauvaise prise staturale et/ou pondérale
- B. Une anémie
- C. Des infections urinaires récidivantes
- D. Une hypertension artérielle
- E. Une tétanie

Réponse A

Une estimation de routine de la filtration glomérulaire est obtenue par mesure de :

- A. Concentration du sodium urinaire
- B. pH urinaire
- C. Clearance de l'inuline
- D. Créatinine et/ou cystatine C plasmatique
- E. Néphrogramme isotopique

Réponse D : créatinine plasmatique

Un garçon de 3 ans 1/2 est admis à l'hôpital avec des oedèmes généralisés. La maladie a débuté 8 jours auparavant par une asthénie et des oedèmes périorbitaires matinaux. L'enfant est apyrétique, a une tension artérielle à 110/60 mmHg et un poids de 16,8 kg (prise de 1,8 kg en une semaine). L'examen d'urine montre une protéinurie à ++++ et l'absence de globules rouges. La protéinurie, quantifiée sur 24 h. est de 70 mg/kg et les albumines plasmatiques sont à 20 g/l.

Devant un tel tableau le diagnostic le plus probable est :

- A. Un lupus érythémateux disséminé
- B. Une glomérulonéphrite aiguë post streptococcique
- C. Un purpura rhumatoïde de Schönlein-Henoch
- D. Un syndrome néphrotique idiopathique
- E. Un syndrome hémolytique urémique

Réponse D : syndrome néphrotique idiopathique

Une coloration anormale des urines, en l'absence d'hématurie, peut être due à toutes les conditions suivantes, sauf à :

- A. Une consommation de betteraves
- B. Un traitement à la rifampicine
- C. Une phénylcétonurie
- D. Une rhabdomyolyse
- E. Une hémolyse intravasculaire aiguë

Réponse C : une phénylcétonurie

L'apparition d'un stridor inspiratoire et d'une toux aboyante chez un petit enfant évoque en premier lieu le diagnostic d'un ou d'une :

- A. Trachéite bactérienne
- B. Faux-croup
- C. Bronchiolite aiguë
- D. Trachéomalacie
- E. Epiglottite

Réponse B : faux-croup

Lors d'une épiglottite aiguë sévère, quelle est la mesure d'urgence la plus importante ?

- A. La tente à oxygène
- B. Les antibiotiques
- C. Les calmants
- D. L'intubation
- E. Les corticostéroïde

Réponse D : l'intubation

Vous suivez une fillette âgée de trois ans en bonne santé habituelle qui a une histoire récente de pyélonéphrite. L'ultrason rénal lors de l'épisode aigu était normal. La cystographie uro-mictionnelle a montré un reflux de grade III du côté gauche. Vous l'avez placée sous un traitement prophylactique d'antibiotiques à petites doses. Parmi les mesures suivantes, quelle est celle que votre prise en charge doit inclure ?

- A. Des cultures d'urines mensuelles
- B. Une scintigraphie à l'acide dimercaptosuccinique (DMSA)
- C. Une cystographie isotopique
- D. Une culture d'urine lors d'épisodes fébriles sans foyer infectieux
- E. Une échographie rénale tous les six mois

Réponse D

La présence d'une hématurie est le plus fréquemment rencontrée au cours :

- A. D'une glomérulonéphrite aiguë
- B. D'une énurésie
- C. D'un syndrome néphrotique
- D. D'une pyélonéphrite chronique
- E. D'une hydronéphrose

Réponse A : d'une glomérulonéphrite aiguë

Au sujet des convulsions fébriles simples, laquelle des affirmations suivantes est vraie ?

- A. Elles sont fréquentes entre 3 et 6 mois.
- B. Elles durent le plus souvent plus de 15 minutes.
- C. Elles sont souvent responsables de lésions cérébrales.
- D. L'électroencéphalogramme (EEG) permet de prédire la survenue ultérieure d'une épilepsie.
- E. Aucune des réponses n'est juste.

Réponse E : aucune